

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

JOSE LUIGI CATERINA

IDADE: 66 PESO: 92 ALTURA: 1,79 PROFISSÃO: *Quente Industrial*

SINTOMAS:

QUEIXAS: *Despertar d' sono à noite; Ronco; Pesadelo; sono agitado*

MEDICAMENTOS: *Aspirina, DM, HAS.*

Escoliose importante

MÉDICO: *Dr Jorge Zanin*

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: *Sedentário*

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S

HORA QUE DORME: *18h - 19h*

HORA QUE ACORDA: *23h depois dorme* *04h 05h*

COCHILO ☒ S () N

DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N *Socialmente FDS. Ativo.*

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: *parou há 20 anos* *4 anos atrás*

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE: *4x*

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: *menor* ☒

MALLAMPATI: *IV*

IAH: *53,9 e/h* SPO2: *85%*

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: *no* *na Norma*

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA *Ablacp 2008*

() ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

2023 Fez cirurgia Adenoma Hipófise

28/10/2024 Abilacp Auto 4 a 12 cmH₂O Max N30C (M)

Em Análise AirView 06/11/24 ↓ 5 a 8,6 cmH₂O.

(IAH: 21,8) → 21/11/24 ↓ P: 6,8 cmH₂O Fixo
AC: 13,3

28/11 P= 6,8 cmH₂O - Pesadelo;

24 IAH= 20,6 e/h - 1x por noite;

m. de uso: 5h30 - Quando ele levanta come.

Dia 26/11 → P= 6,8 cmH₂O / IAH= 3,9 e/h / m. de uso: 6h23'

Domingo ↑ 0 IAH

levanta 8h

assiste TV cochila

almoço

dorme de novo

Jos

SpO₂ 92%

FC: 83 bpm

23/12/2024

P: 6,8 cmH₂O
IAH: 15,1 e/h

AC: 9,5
AO: 1,6

muro: 27 l/min

fuga: 6228 min

↓ P: 6,4 cmH₂O
↑ humidif: 5

23/01/25

P: 6,4 cmH₂O

IAH: 16,8 e/h

m de uso: 6h6'

fuga: 4,1 l/m

AC: 9,6

AO: 4,4

↑ P: ~~7,0~~ cmH₂O

Natacha

03/07

25

P: 7 cmH₂O

IAH: 16,1 e/h

m. de uso: 3h23'

fuga: 9,5 lpm.

↓ a arritmia

↓ o sono agitado

Nome: JOSÉ LUIGI CATERINA
Data de Nascimento: 3-3-1958
IMC: 29,04
Sexo: Masculino
Data do exame: 14-08-2024

Peso: 92 kg
Altura: 1,78 m
Médico: DR. JORGE ZARUR NETO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 14-08-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 456,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 91,0 e 120,5 minutos. O tempo total de sono foi de 331,5 min, eficiência de 72,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,0%; estágio N2: 73,0%; estágio N3: 4,8%; sono REM: 19,2%. O índice de despertares foi de 34,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 53,9/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 293 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 85%, permanecendo 1,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 85 bpm e NREM de 53 - 84 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 53,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=85%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (19,4/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157



DR.
LUCIANO
ROTELLA

OTORRINOLARINGOLOGIA E SONO

Dr. Luciano Rotella

Título de Especialista em
Otorrinolaringologia.
ABORL - CCF

Especialista em Medicina
e Biologia do Sono - AMB

Graduação médica - UNIFESP
Escola Paulista de Medicina.

Dr. L. Rotella

Solicito para tratamento de SAOS

CID: G47.3

() CPAP com pressão titulada de _____ cm H₂O

() BIPAP com pressão insp de _____ cm H₂O e exp
_____ cm H₂O

(X) CPAP com pressão sugerida de 9 cm H₂O e
relatório após 20 dias de uso

(12) 3923-4000

Avenida 9 de Julho, 765,
1º Andar, Ed. Apollo Center,
São José dos Campos

Dr. Luciano Rotella
Otorrinolaringologista
CRM 111556

www.drlicianorotella.com